

**Objectif 1 /2 :**

---

**1) Les facteurs de risques exogènes des cancers colorectaux sont :**

- A. Le tabagisme
- B. L'alimentation riche en graisse et en viande
- C. La consommation d'aspirine
- D. L'alimentation riche en fibres végétales
- E. La sédentarité

**2) Le cancer colorectal est :**

- A. Une tumeur maligne du tube digestif allant de la valvule iléo-caecale jusqu'au canal anal
- B. Le deuxième cancer digestif en termes de fréquence
- C. Le plus souvent un adénocarcinomes lieberkühniens
- D. Une tumeur de mauvais pronostic
- E. Une tumeur maligne qui se développe sur un état précancéreux

**3) Les facteurs de risques endogènes des cancers colorectaux sont :**

- A. La rectocolite ulcéro-hémorragique
- B. La diverticulose colique
- C. La maladie de Crohn
- D. L'angiodysplasie colo rectale
- E. Le diverticule de Meckel

**4) Parmi ces facteurs endogènes, lequel est le plus incriminé dans la survenue de CCR? :**

- A. PAF
- B. Polype adénomateux sporadique
- C. RCH
- D. HNPCC
- E. Syndrome de Gardner

**5) Le polype adénomateux colorectal est associé à un risque de dégénérescence plus élevé :**

- A. Lorsqu'il est ancien
- B. Lorsqu'il est de type tubuleux
- C. Lorsqu'il est sessile
- D. Lorsqu'il est de siège rectal
- E. Lorsqu'il est de taille > 1 cm

**6) Le risque de dégénérescence de RCH augmente avec :**

- A. L'âge avancé lors du diagnostic de RCH
- B. L'association à une CSP
- C. L'étendue de la RCH
- D. L'association à une fistule anale chronique
- E. L'association à une dysplasie

**7) La Polypose Recto-colique Familiale (PAF) :**

- A. Est une maladie héréditaire à transmission autosomique récessive
- B. Est une maladie secondaire à une mutation du gène APC situé sur le chromosome 5
- C. Est responsable de 1% des cancers colorectaux
- D. Est associée à un risque de dégénérescence évalué à 700/0 après 10 ans d'évolution
- E. Est définie par une muqueuse colorectale tapissée de polypes

**8) La Polypose Recto-colique Familiale (PAF) Floride :**

- A. Est une maladie héréditaire à transmission autosomique dominante
- B. Est secondaire à une mutation du gène APC situé sur le chromosome 1
- C. Est associée à un risque de dégénérescence de 100% à l'âge de 40 ans
- D. Est associée un à risque de CCR multifocal
- E. Est définie par une muqueuse colorectale tapissée de polypes

**9) Le syndrome de cancer colique familial sans polypose (HNPCC) :**

- A. Est à transmission autosomique dominante avec faible pénétrance
- B. Est responsable de 15 % des cancers colorectaux
- C. Est secondaire à une mutation du gène MMR
- D. Peut associer des cancers gynécologiques (ovaire et utérus)
- E. Peut associer des cancers de l'appareil urinaire

**10) Le risque de survenu de cancer CCR est élevé en cas de :**

- A. ATCD personnel de CCR
- B. La polypose adénomateuse
- C. Un apparenté au 1<sup>er</sup> degré ayant un adénome à l'âge de 65 ans
- D. Maladie inflammatoire de l'intestin
- E. Syndrome de Lynch

**11) Le risque de survenu de cancer CCR est très élevé en cas de :**

- A. ATCD personnel de CCR
- B. La polypose adénomateuse
- C. Un apparenté au 1<sup>er</sup> degré ayant un adénome à l'âge de 65 ans
- D. Maladie inflammatoire de l'intestin
- E. Syndrome de Lynch

**Objectif 3 :**

---

**12) L'angle colique gauche :**

- A. Fait partie du colon transverse
- B. Est en rapport avec le pôle inférieur de la rate
- C. Répond en arrière au corp du pancréas
- D. Répond en arrière au pôle supérieur du rein gauche
- E. Vient au contact de la 2<sup>ème</sup> portion du duodénum et la face postérieure de l'estomac

**13) Le colon transverse :**

- A. Répond en avant à la vésicule biliaire
- B. Est en rapport avec le duodénum et avec la tête du pancréas
- C. Répond à l'angle duodéno-jéjunale à droite
- D. Est un segment fixe du colon
- E. Est de calibre moins important que le colon gauche

**14) La vascularisation artérielle colique :**

- A. Est tributaire de l'artère mésentérique supérieure à gauche
- B. Est tributaire de l'artère iliaque gauche pour le colon sigmoïde
- C. Est anastomotique entre 2 systèmes par l'arcade de Riolan
- D. Vascularise aussi l'intestin grêle par l'intermédiaire de l'artère mésentérique supérieure
- E. Est de type terminale

**15) L'artère mésentérique supérieure :**

- A. Vascularise l'intestin grêle
- B. Vascularise le colon droit
- C. Naît de la face antérieure de l'aorte abdominale, en regard de la deuxième vertèbre lombaire (L2)
- D. Participe à la vascularisation du bloc duodéno-pancréatique
- E. Chemine en avant du pancréas

**16) La veine mésentérique supérieure :**

- A. Naît de la confluence des veines rectales supérieures, des veines sigmoïdiennes et de la veine colique gauche
- B. Fusionne avec la veine splénique pour former le tronc spléno-mésaraïque
- C. Naît dans le mésentère, près de la valvule iléo-caecale
- D. Chemine à droite de l'artère mésentérique supérieure
- E. Se jette dans le tronc porte

**17) Le tronc gastro-colique de Henlé correspond à la réunion des veines :**

- A. Gastro-épiploïque droite
- B. Pancréatico-duodénale postérieure
- C. Colique supérieure droite
- D. Colique moyenne
- E. Rénale droite

**18) Le drainage lymphatique du colon :**

- A. Est anarchique, mal systématisé
- B. Se répartit en 5 groupes
- C. Explique le fait que les cancers du côlon gauche donnent plutôt des métastases du foie gauche
- D. Est la voie empruntée par les métastases hépatiques
- E. Suit les pédicules artério-veineux dans les mésos

**19) Le rectum :**

- A. Peut être divisé en 4 parties sur le plan chirurgical
- B. Est le segment terminale du tube digestif
- C. À la forme d'un réservoir cylindrique de 15 cm de long
- D. Fait suite au côlon sigmoïde au niveau de la 2<sup>ème</sup> vertèbre sacrée
- E. Comporte deux parties : le rectum pelvien, ou ampoule rectale et le rectum périnéal ou canal anal

**20) Le rectum :**

- A. Traverse le petit bassin de haut en bas dans sa moitié postérieure
- B. Est entouré d'une séreuse sur toute sa hauteur
- C. Est divisé en deux parties par le péritoine
- D. Est enveloppé, surtout sur sa face antérieure, d'un tissu cellulo-grasieux appelé mésorectum
- E. Sous-péritonéal est entouré par un feuillet viscéral ou Fascia Recti

**21) Un cancer de la paroi antérieure du rectum risque d'envahir :**

- A. L'aponévrose de Denonvilliers
- B. L'aponévrose de Waldeyer
- C. Le vagin
- D. Les vésicules séminales
- E. Le sacrum

**22) Le rectum :**

- A. En postérieur répond au sacrum par l'intermédiaire de l'aponévrose pré-sacrée
- B. En antérieur, chez l'homme, répond à l'aponévrose prostatopéritonéale de Denonvilliers
- C. Dans sa partie sus-péritonéale, répond à l'urètre
- D. En antérieur, chez la femme, répond à la face postérieure de la vessie
- E. Dans sa partie sus-péritonéale, peut être en rapport avec l'appendice

**23) La vascularisation artérielle du rectum est assurée par :**

- A. L'artère rectale supérieure
- B. Les artères rectales moyennes
- C. Les artères rectales inférieures
- D. Le tronc des artères sigmoïdiennes
- E. L'artère vaginale postérieure

**24) À propos le drainage lymphatique, le rectum est drainé par :**

- A. Les hémorroïdaux supérieurs
- B. Les ganglions du mésorectum
- C. Le ganglion de Mondor
- D. Les ganglions inguinaux profonds
- E. Les ganglions rétro-sacrés

**25) Les cancers colo-rectaux en macroscopie sont :**

- A. D'aspect qui varie selon le siège de la tumeur
- B. Ulcérées et en virole dans les segments du colon droit
- C. Le plus souvent d'une forme ulcéro-infiltrante
- D. Bourgeonnantes et peu ulcérées au niveau du côlon gauche
- E. Saignantes et fragiles

**26) L'extension locorégionale des CCR :**

- A. Se fait en profondeur formant une tumeur sténosante
- B. Se fait dans 3 sens
- C. Se fait en latéral surtout pour le colon sigmoïde
- D. Se fait en profondeur et c'est à la base des classifications histo-pronostiques
- E. En longitudinal, permet de définir la clairance latérale

**27) Une tumeur du côlon est classée T3 lorsqu'elle envahit :**

- A. La sous-séreuse
- B. La séreuse
- C. Le Mésocolon
- D. Un organe de voisinage
- E. Une frange épiploïque

**28) Un adénocarcinome bien différencié qui envahit la musculature avec aucun ganglion envahi et absence de métastases à distance.**

**La tumeur est classée :**

- A. pTis N0 M0
- B. pT1 N0 M0
- C. pT2 N0 M0
- D. pT3 N0 M0
- E. pT4 N0 M0

#### **Objectif 4 + 5 :**

---

**29) Les circonstances de découverte des cancers coliques sont :**

- A. Les ténesmes
- B. Les épreintes
- C. La fièvre au long cours
- D. Les troubles dyspeptiques
- E. Le syndrome de Koenig

**30) Les circonstances de découverte du cancer rectal sont :**

- A. Les faux besoins
- B. Les mélénas
- C. Les épreintes
- D. Les ténesmes
- E. Splénomégalie

**31) Un CCR peut-être découvert à l'occasion de :**

- A. Une altération de l'état général
- B. Une douleur de type solaire
- C. Une fécalurie
- D. Des coliques hépatique
- E. Un syndrome occlusif

**32) Le toucher rectal :**

- A. Fait partie du bilan d'extension du cancer du rectum
- B. Apprécie la résécabilité d'un cancer du rectum
- C. Permet d'évoquer le diagnostic du cancer du rectum dans près de 100% des cas
- D. Permet d'apprécier le siège de la tumeur rectale par rapport au plan des releveurs
- E. Fait partie du bilan d'extension du cancer du colon

**33) Devant une tumeur du haut rectum sténosant, la colonoscopie :**

- A. Doit être couplée à une coloration à l'indigo-carmin
- B. Doit explorer tout le cadre colique si possible
- C. Est l'examen de référence pour apprécier la distance par rapport à la marge anale
- D. Nécessite une préparation colique rapide et adéquate
- E. Nécessite une anesthésie générale

**Objectif 5 :**

---

**34) Le bilan d'extension tumorale du cancer du côlon comporte :**

- A. Un scanner thoraco-abdomino-pelvien
- B. Un colo-scanner
- C. Une coloscopie totale
- D. Une vidéoscopie par vidéo-capsule si tumeur colique sténosante
- E. Un toucher rectal

**35) Le bilan d'extension d'une grosse tumeur du rectum palpée au TR comporte :**

- A. Un examen clinique
- B. Une colonoscopie totale
- C. Une IRM pelvienne
- D. Une écho-endoscopie
- E. Une IRM hépatique

**36) Devant un cancer du rectum, l'IRM pelvienne est demandée pour apprécier :**

- A. La marge circonférentielle
- B. Le siège exacte de la tumeur
- C. L'atteinte ganglionnaire
- D. L'envahissement des couches de la paroi rectale
- E. L'extension à distance

**37) En cas de cancer rectal, L'échographie endorectale (EER) représente l'examen de référence pour :**

- A. Préciser le degré d'infiltration du méso rectum
- B. Permettre un bilan d'extension loco-régionale en cas de sténose rectale
- C. Préciser l'extension aux organes de voisinage
- D. Évaluer le degré d'infiltration pariétale d'une petite tumeur
- E. Évaluer l'extension ganglionnaire

**Objectif 7 :**

---

**38) Les principes généraux du traitement curatif chirurgical des CCR comportent :**

- A. Une adaptation au terrain du patient
- B. Une voie coelioscopique qui est recommandée
- C. Une marge de sécurité d'au moins 4 cm de part et d'autre de la tumeur
- D. Une exploration de toute la cavité abdominale après le geste de résection
- E. Un curage ganglionnaire associé

**39) Le traitement chirurgical du cancer du côlon droit non compliqué consiste à pratiquer :**

- A. L'exérèse de la tumeur avec marge de résection maximale de 5cm de part et d'autre
- B. La résection systématique de la dernière anse iléale
- C. La résection systématique de la moitié droite du côlon transverse
- D. Un curage ganglionnaire nécessitant la ligature section de l'AMS avant la naissance de l'artère colique droite
- E. Une anastomose digestive pour rétablir la continuité digestive

**40) L'hémi colectomie gauche vraie pour le traitement chirurgicale du cancer du côlon gauche non compliqué comporte :**

- A. Une résection de tout le côlon gauche depuis l'union  $\frac{1}{3}$  moyen-  $\frac{1}{3}$  gauche du côlon transverse jusqu'à la jonction recto-sigmoïdienne
- B. Une ligature de l'artère mésentérique inférieure à son origine
- C. Une anastomose iléo-rectale pour rétablir la continuité digestive
- D. Une ligature de la VMS au bord supérieur du pancréas
- E. Un curage ganglionnaire aortique

**41) À propos les particularités du traitement chirurgical du cancer du côlon transverse non compliqué :**

- A. La colectomie transverse est l'intervention de référence
- B. On peut pratiquer une hémi-colectomie droite avec anastomose iléo-transverse
- C. On peut pratiquer une hémi-colectomie gauche avec anastomose colorectale
- D. On peut pratiquer une colectomie totale avec anastomose iléo-rectale
- E. Le curage ganglionnaire n'est pas recommandé pour cette localisation

**42) L'indication d'une colectomie totale est portée devant :**

- A. Une maladie de Crohn iléo-caecale dégénéré
- B. Une PAF Floride dégénérée
- C. La présence de 2 cancers synchrones du colon droit et gauche
- D. Une perforation diastatique du caecum secondaire à un cancer du côlon gauche
- E. Une perforation d'un cancer colique gauche

**43) Le traitement chirurgicale d'un cancer colique en occlusion peut être fait par :**

- A. Une colostomie première de décharge
- B. Une hémi colectomie droite avec anastomose iléo-transverse pour les cancers du côlon droit
- C. L'intervention de Bouilly Volkmann pour un cancer de l'angle colique gauche
- D. L'intervention de Hartmann pour un cancer du côlon droit
- E. Une Colectomie totale avec anastomose iléo-rectale pour un cancer de l'angle colique droit avec des lésions ischémiques du cæcum

**44) Après exérèse local d'un polype rectal en mono bloc, celle-ci est suffisante si l'examen anatomopathologique conclut à :**

- A. Un cancer in situ
- B. Des marges de section positives
- C. Un polype hyperplasique
- D. Un cancer invasif :T2
- E. Un ADK indifférencié

**45) La chimiothérapie pour le traitement des cancers coliques :**

- A. Est indiquée en adjuvant pour les tumeurs avec atteinte ganglionnaire à l'histologie (N+)
- B. A pour but de réduire le risque de récurrence
- C. Est indiquée en adjuvant pour toutes les tumeurs classées T3N0M0
- D. A pour but de prolonger la survie
- E. Est discutée en RCP (réunion de concertation pluridisciplinaire) seulement si présence des facteurs de mauvais pronostic

**46) Les principes généraux du traitement chirurgicale du cancer du rectum sont :**

- A. Des marges distales minimale de résection de 5 cm
- B. L'exérèse totale extra fasciale du mésorectum pour les tumeur du moyen rectum
- C. Le curage ganglionnaire mésentérique inférieur
- D. Le curage ganglionnaire iliaque primitif
- E. La conservation de l'innervation pelvienne

**47) Le traitement chirurgical du cancer du haut rectum :**

- A. Se fait par voie abdominale
- B. Nécessite une résection du rectum et du mésorectum jusqu'à 5 cm sous le pôle inférieur de la lésion
- C. Nécessite la ligature de l'AMS à son origine
- D. Emporte l'appareil sphinctérien
- E. Se fait par une résection antérieure du rectum

**48) Le traitement chirurgical du cancer du moyen rectum :**

- A. Se fait par une résection antérieure du rectum
- B. Nécessite un rétablissement de continuité digestive par anastomose colorectale basse
- C. Doit emporter la tumeur avec une marge distale de 5 cm
- D. Permet une conservation sphinctérienne anale
- E. Sera protégé par une iléostomie ou une colostomie

**49) Le traitement chirurgical du cancer du bas rectum :**

- A. Nécessite une exérèse complète du méso rectum
- B. Peut être assuré par une résection antérieure
- C. Peut être assuré par une amputation abdomino-périnéale
- D. Comporte un curage iliaque interne
- E. Comporte une ligature des 2 artères hypogastriques

**Objectif 8 :**

---

**50) Les facteurs de mauvais pronostic des CCR sont :**

- A. Le stade TNM avancé
- B. L'instabilité micro satellitaire « MSI »
- C. Les tumeurs occlusives
- D. Le caractère bien différencié
- E. L'engainement péri-nerveux

**51) Le taux de survie relative à 5 ans des CCR est de :**

- A. 60% pour les cancers stade I
- B. 50% pour les cancers stade II
- C. 20% pour les cancers stade III
- D. 5% pour les cancers stade IV
- E. 60% quel que soit le stade

**Objectif 9 :**

---

**52) Les éléments de surveillances postopératoire des CCR sont :**

- A. L'examen clinique
- B. L'échographie abdominale
- C. La radio-thorax
- D. Le dosage des CA125
- E. L'endoscopie basse tous les 6 mois

### **Cas Clinique :**

Un homme de **65 ans** consulte pour **rectorragies** évoluant depuis **6 mois**.

L'examen trouve un patient avec état hémodynamique stable, pas de masse abdominale palpable.

L'examen de la marge anale conclut à des hémorroïdes internes prolabées Grade 3, le toucher rectal trouve un doigtier souillé de sang, pas de masse palpable.

#### **1) Que proposez-vous ?**

- A. Traitement anti hémorroïdaire
- B. Angioscanner abdominal
- C. Vidéo-Capsule
- D. Rectoscopie
- E. Lavement Baryté

Une **recto-sigmoïdoscopie** a été faite montre la présence d'une lésion bourgeonnante, irrégulière, saignant au contact, à **6 cm** de la marge anale.

Les biopsies de cette tumeur a montrés la présence d'un **adénocarcinome bien différencié**.

Après un bilan d'extension par TDM TAP et IRM pelvienne la tumeur a été classée **T3N+M0**

#### **2) Quel traitement envisagez-vous :**

- A. Une amputation abdomino-périnéale précédée d'une radio-chimiothérapie
- B. Résection antérieure du rectum précédée d'une radio-chimiothérapie
- C. Résection chirurgicale de la tumeur par voie endo-anale
- D. Intervention de Hartmann
- E. Radiothérapie exclusive

L'examen anatomopathologique de la pièce opératoire montre la présence d'un adénocarcinome bien différencié classé T3N1M0 avec engainement péri nerveux et embolies vasculaires.

#### **3) Quels sont les éléments de mauvais pronostic chez ce patient :**

- A. L'atteinte en profondeur de la paroi colique
- B. L'atteinte ganglionnaire
- C. L'engainement péri-nerveux
- D. Le caractère bien différencié de la tumeur
- E. L'aspect végétant ou ulcéreux de la tumeur

#### **4) Quel est votre CAT en post-opératoire ?**

- A. Une surveillance : contrôle dans 3 mois
- B. Une hormonothérapie
- C. Une radio-chimiothérapie adjuvante
- D. Une chimiothérapie adjuvante
- E. Une curie thérapie endo anale adjuvante

#### **5) Votre protocole de surveillance sera composé d' :**

- A. Une coloscopie totale
- B. Un scanner pelvien
- C. Une échographie abdomino-pelvienne
- D. Un scanner TAP
- E. Un dosage de l'antigène carcino-embryonnaire